

학교 호발 감염병 관리 가이드

보건교사 역량강화 연수자료

인플루엔자 · 급성호흡기감염증(바이러스성·세균성) · 백일해 · 수두 · 볼거리 · 성홍열 · 수족구병 · 노로바이러스 ·
유행성농병 · 머릿니

자료 안내

본 자료는 학교 현장에서 자주 발생하는 감염병 10종을 선정하여, 보건교사가 신속하게 참고할 수 있도록 원인 · 증상 · 등교중지 기준 · 예방접종 · 현장 대응 포인트를 표준화된 형식으로 정리한 것입니다.

등교중지 기준은 「학교보건법」 및 교육부 「학교 감염병 예방·위기대응 매뉴얼」, 질병관리청 감염병 포털 자료를 바탕으로 작성하였으나, 실제 적용 시에는 반드시 의사 소견서 및 최신 지침을 함께 확인하시기 바랍니다.

※ '급성호흡기감염증'은 제4급 법정감염병(표본감시 대상)으로, 병원체에 따라 바이러스성(파라인플루엔자·리노바이러스 등)과 세균성(마이코플라스마 폐렴균 등)으로 구분됩니다. 최근 유행 흐름을 반영해 두 유형을 별도 항목(2, 3번)으로 나누어 정리하였습니다.

목차

1. 인플루엔자 — 겨울~초봄(12~3월), 학령기 2차 유행(봄)
2. 급성호흡기감염증 - 바이러스성 (파라인플루엔자·리노바이러스 등) — 계절 구분 없이 상시 발생, 최근 여름철에도 높은 검출률
3. 급성호흡기감염증 - 세균성 (마이코플라스마 폐렴균 감염증) — 3~4년 주기 유행, 최근 겨울철(2023~2024년) 대유행 — 학교 현장 최근 최다 발생 사례
4. 백일해 — 봄~초여름 유행 확산, 학령기(7~19세) 집중
5. 수두 — 봄철(4~6월) 집중 유행
6. 유행성이하선염(볼거리) — 봄철(4~6월), 5~15세 다발
7. 성홍열 — 늦겨울~초봄, 6~12세 다발
8. 수족구병 — 여름철(6~9월), 영유아·초등 저학년 다발
9. 노로바이러스 감염증 — 겨울철(11~2월) 집단발생 다발
10. 유행성각결막염(눈병) — 학기 초·여름철 다발
11. 머릿니 — 학기 초, 집단생활 시설에서 상시 발생 가능

1. 인플루엔자 (Influenza) [호발 시기: 겨울~초봄(12~3월), 학령기 2차 유행(봄)]

감염병 등급	제4급 법정감염병 (표본감시)
원인·전파경로	인플루엔자바이러스 / 비말감염, 접촉감염
잠복기	1~4일 (평균 2일)
주요 증상	38°C 이상 고열, 심한 두통·오한·근육통, 인후통, 기침, 콧물 (소아는 구토·설사 동반 가능)
등교중지 기준	해열제 없이 정상체온 회복 후 24시간 경과할 때까지 (해열제 투약 시 마지막 투약 후 48시간 경과)
예방접종	매년 접종 권장 (생후 6개월 이상 전 국민 대상, 특히 학령기·고위험군)
현장 대응 포인트	질병관리청 표본감시 주간소식지의 의사환자분율(ILI) 및 연령별 검출률을 매주 확인하여 유행 조짐을 조기에 파악. 발열 학생 조기 귀가 및 마스크 착용 안내.

2. 급성호흡기감염증 - 바이러스성 (파라인플루엔자·리노바이러스 등)

(Acute Respiratory Infection (Viral)) [호발 시기: 계절 구분 없이 상시 발생, 최근 여름철에도 높은 검출률]

감염병 등급	제4급 법정감염병 (표본감시) — 급성호흡기감염증 중 바이러스성 병원체
원인·전파경로	파라인플루엔자바이러스, 리노바이러스, 아데노바이러스, 사람메타뉴모바이러스 등 다양한 호흡기 바이러스 / 비말·접촉감염
잠복기	바이러스별로 상이 (파라인플루엔자 2~6일)
주요 증상	상기도감염 증상 위주. 파라인플루엔자는 소아 후두염(크룹) 유발 — 쾅쾅거리는 기침, 쉼 목소리, 흡기성 천명이 특징적
등교중지 기준	법정 격리기간이 별도 고시되어 있지 않아 증상 중심으로 판단. 발열 동반 시 인플루엔자 기준(정상체온 회복 후 24시간)에 준하여 안내, 크룹 의심 증상은 즉시 진료 권고
예방접종	없음 (특정 백신·항바이러스제 부재 — 대증치료 중심)
현장 대응 포인트	인플루엔자와 증상이 유사해 혼동되기 쉬우므로 '쾅쾅거리는 기침 + 흡기성 천명'이 있으면 크룹을 의심하고 조기 진료를 권고. 손씻기·기침 예절 등 기본 방역수칙 반복 안내가 핵심.

3. 급성호흡기감염증 - 세균성 (마이코플라스마 폐렴균 감염증) (Acute

Respiratory Infection (Mycoplasma pneumoniae)) [호발 시기: 3~4년 주기 유행, 최근 겨울철(2023~2024년) 대유행 — 학교 현장 최근 최대 발생 사례]

감염병 등급	제4급 법정감염병 (표본감시) — 급성호흡기감염증 중 세균성 병원체
원인 · 전파경로	마이코플라스마 폐렴균(세균) / 비말감염, 가족·학교 등 밀집 환경에서 전파
잠복기	2~3주 (잠복기가 길어 학급 내 유행이 수주간 지속될 수 있음)
주요 증상	발열·두통·콧물·인후통으로 시작해 2주 이상 지속되는 기침. 5세 미만 영유아는 천명음·구토·설사 등 다른 양상을 보이기도 함. 일부 중증 비정형 폐렴으로 진행 가능
등교중지 기준	법정 등교중지 의무 규정은 없으나, 호흡기 증상이 있는 동안 등교·등원 자제 및 재택 휴식 권고. 미등원 시에도 법정감염병에 따른 결석으로 출석 인정
예방접종	없음 (항생제 치료로 관리 — 마크로라이드계 항생제 반응 양호하나 최근 내성균 증가 추세)
현장 대응 포인트	잠복기가 길어 초기 통제가 어려우므로, 기침이 2주 이상 지속되는 학생은 조기에 진료를 권고. 질병관리청이 표본감시 입원환자수 2주 연속 250명 이상 시 유행주의보를 발령하므로 겨울철 발령 여부를 주기적으로 확인.

4. 백일해 (Pertussis) [호발 시기: 봄~초여름 유행 확산, 학령기(7~19세) 집중]

감염병 등급	제2급 법정감염병
원인 · 전파경로	보르데텔라 백일해균 / 비말감염, 가족 내 2차 발병률 최대 80%
잠복기	4~21일 (평균 7~10일)
주요 증상	카타르기(콧물·눈물·경미한 기침, 1~2주) → 경해기(발작성 기침, 흡기 시 whoop 소리, 기침 후 구토, 2~6주) → 회복기(2~3주)
등교중지 기준	유효 항생제(azithromycin, clarithromycin) 복용 시 복용 시작 후 5일 경과 후 등교 가능. 미치료 시 기침 발작 시작 후 최소 3주간 등교중지
예방접종	DTaP(영유아 기초접종), 11~12세 Tdap 추가접종, 이후 10년마다 성인 Tdap/Td 재접종
현장 대응 포인트	임신부(27~36주 권장) 및 영아와 밀접 접촉하는 교직원의 Tdap 접종력 확인. 카타르기 증상은 감기와 구분이 어려워 조기 발견이 어려우므로 학급 내 지속되는 기침에 유의.

5. 수두 (Varicella (Chickenpox)) [호발 시기: 봄철(4~6월) 집중 유행]

감염병 등급	제2급 법정감염병
원인·전파경로	수두대상포진바이러스(VZV) / 공기전파, 수포 병변 직접 접촉
잠복기	10~21일 (평균 14~16일)
주요 증상	미열로 시작하여 전신에 발진성 수포(물집) 발생, 몸통·두피·안면·팔다리에 무리지어 나타남
등교중지 기준	모든 피부병변에 가피(딱지)가 형성될 때까지 (발진 발생 후 최소 5일간)
예방접종	생후 12~15개월 1회 접종 (국가필수예방접종)
현장 대응 포인트	잠복기가 길어 노출 후에도 한동안 무증상일 수 있음에 유의. 접종력 없는 학생 파악 및 학급 내 수포성 발진 학생 조기 격리 안내.

6. 유행성이하선염(볼거리) (Mumps) [호발 시기: 봄철(4~6월), 5~15세 다발]

감염병 등급	제2급 법정감염병
원인·전파경로	유행성이하선염바이러스 / 비말감염
잠복기	2~3주 (평균 16~18일)
주요 증상	귀밑 침샘(이하선) 부종·통증, 씹거나 삼킬 때 통증 증가, 발열·두통·근육통 동반 가능
등교중지 기준	이하선염 증상 발생 후 5일까지 등교중지
예방접종	MMR 1차(생후 12~15개월), 2차(만 4~6세)
현장 대응 포인트	가벼운 침샘염과 혼동해 등교중지 없이 등교하는 사례가 있어 유의. 역학적으로 강하게 의심되면 진단검사 권고.

7. 성홍열 (Scarlet Fever) [호발 시기: 늦겨울~초봄, 6~12세 다발]

감염병 등급	제2급 법정감염병
원인·전파경로	A군 베타용혈성연쇄구균 / 비말감염, 분비물 직접 접촉

잠복기	1~7일 (평균 2~5일)
주요 증상	갑작스런 고열, 인후통, 두통, 구토, 몸통에서 시작해 퍼지는 선홍색 미만성 발진, 딸기혀
등교중지 기준	항생제 치료 시작 후 24시간까지 자택 격리 (동일 학급 7일 이내 2명 이상 발생 시 '유행'으로 관리)
예방접종	없음 (항생제 치료로 관리)
현장 대응 포인트	항생제 치료 시작 후 비교적 빠르게(24시간) 등교가 가능한 질환이므로, 진단서상 치료 시작일을 확인해 등교중지 기간을 정확히 안내.

8. 수족구병 (Hand, Foot and Mouth Disease) [호발 시기: 여름철(6~9월), 영유아·초등 저학년 다발]

감염병 등급	비법정 (표본감시 대상)
원인·전파경로	코사키바이러스 등 장바이러스 / 비말감염, 분변-경구 감염, 수포 접촉
잠복기	3~7일
주요 증상	손·발바닥, 입안 수포성 발진, 발열, 인후통 (구내 병변으로 섭식 곤란 가능)
등교중지 기준	수포 발생 후 6일간 또는 모든 병변에 가피가 형성될 때까지 등교중지 권고
예방접종	없음
현장 대응 포인트	저학년·유치원과 협업이 필요한 질환. 손씻기 및 장난감·집기 소독 강조, 급식 전후 위생관리 연계.

9. 노로바이러스 감염증 (Norovirus Infection) [호발 시기: 겨울철(11~2월) 집단발생 다발]

감염병 등급	제2급 법정감염병 (장관감염증 표본감시)
원인·전파경로	노로바이러스 / 분변-경구감염, 구토물을 통한 비말전파, 오염된 식품·물
잠복기	12~48시간
주요 증상	급성 구토, 설사, 복통, 미열
등교중지 기준	구토·설사 증상이 사라진 후 48시간이 경과할 때까지 등교중지
예방접종	없음

현장 대응 포인트	급식실과 연계한 위생관리가 핵심. 구토물 처리 시 표준 프로토콜(염소계 소독제 사용, 즉시 격리) 준수 여부를 사전에 점검.
-----------	---

10. 유행성각결막염(눈병) (*Epidemic Keratoconjunctivitis*) [호발 시기: 학기 초·여름철 다발]

감염병 등급	비법정 (감염력이 강해 격리 권고)
원인·전파경로	아데노바이러스 / 눈 분비물 직접·간접 접촉(수건, 손 등 공유)
잠복기	5~12일
주요 증상	눈 충혈, 눈곱, 이물감, 눈부심, 눈물흘림 (한쪽 눈에서 시작해 양쪽으로 번지는 경우 많음)
등교중지 기준	전염력이 강한 첫 증상일로부터 2주간 격리 권고 (의사 소견서에 기간 명시가 없는 경우도 통상 2주 기준 안내)
예방접종	없음
현장 대응 포인트	개인 수건 사용, 눈 만지지 않기 교육이 예방의 핵심. 법정감염병이 아니어서 등교중지를 두고 학부모와 이견이 생기기 쉬우므로 안내 문구를 사전에 표준화해 둘 것을 권장.

11. 머릿니 (*Pediculosis Capitis*) [호발 시기: 학기 초, 집단생활 시설에서 상시 발생 가능]

감염병 등급	비법정 (법정감염병 아님)
원인·전파경로	머릿니 / 두피 간 직접 접촉, 빗·모자·베개·헤어핀 등 개인용품 공유
잠복기	서캐(알) 부화까지 약 6~10일
주요 증상	두피 가려움증, 두피 및 모발에서 이·서캐(알) 육안 확인 가능
등교중지 기준	법적 등교중지 의무는 없음. 전용 샴푸 등으로 치료를 병행하며 등교 가능하나, 개인용품 공유 금지 등 확산 방지 조치가 필요
예방접종	없음
현장 대응 포인트	질병이 아닌 '위생 문제'로 인식되어 학부모가 민감하게 반응할 수 있는 사안. 낙인 없이 학급 전체 대상 안내문을 발송하는 방식이 효과적.